

■ フレイル／術前リハビリ

虚弱高齢者の術前リハ、3週30回でも1年後の要介護度の悪化を防げず

ドイツ19病院1,382人の評価者盲検RCT(PRAEP-GO)

主要評価は術後12か月の要介護度(0～5の6段階)の変化。解析対象1,199人(中央値78歳、女性54%、整形外科手術51%)で、群間差は -0.1(95%CI -0.25～0.07)と有意差はなかった。

介入群の安全性事象は32件で、多くは介入と無関係か関連の可能性にと

どまった。実施率は高く、「やり切れなかった」ことが原因ではない。

著者らは短期の監督下プレハブを一律の術前ルートにすべきでないとし、より長い行動変容型の介入、参加を促す工夫、効果が見込める対象の特定を優先すべきと提言した。



一律に短く、ではなく、誰に・どれだけ長く

出典 [Lancet Healthy Longevity](#) ↗

数字で見る

1,382人

無作為化した70歳以上(19病院)

29.5 /30回

監督下セッション実施の中央値

-0.1 段階

12か月の要介護度変化の群間差(有意差なし)

■ 大腿骨骨折／麻酔

大腿骨骨折の手術、脊椎と全身麻酔で30日の死亡・重い心肺合併症に差なし

登録の遅れで目標の75%で早期中止となり検出力が不足、割り付けと違う麻酔への切り替えも多かった。著者らは個別に麻酔法を選ぶ方針を支持するとしている。



出典 [Lancet Healthy Longevity](#) ↗

■ 介護報酬改定／地域

中山間・離島の自治体、訪問・送迎の移動コストの報酬評価を要望

同日、リハ専門職団体協議会は訪問リハ事業所のない自治体が約4割あるとして、こうした地域の提供体制の拡充を求めた。今後は個別サービスの見直しに議論が移る。



出典 [PT-OT-ST.NET\(第267回介護給付費分科会\)](#) ↗

短信

〈退院支援〉**高齢者の退院後フォロー、デジタルは続く**

46研究のSR。継続率・満足度は良好、再入院と心の健康への効果は一貫せず 出典 [Lancet Healthy Longev](#) ↗

〈脳出血／フレイル〉**虚弱でも急性期ケアの束は有効か**

INTERACT3の7,035人を再解析。虚弱で死亡HR1.48、ケアの効果は虚弱の有無で変わらず 出典 [Lancet Healthy Longev](#) ↗

〈人工膝関節〉**TKA後の遠隔リハ、イランで実施可能**

30人の予備的RCT。継続率90%、84.6%が推奨。臨床効果は本試験待ち 出典 [BMJ Open](#) ↗

〈脳卒中／嚥下〉**脳卒中後の胃ろう、医師は効果を高く見積もる**

米神経内科医64人の調査。87.5%が有益と回答、72%が発症2週後を好む 出典 [J Stroke Cerebrovasc Dis](#) ↗

〈医療AI〉**診察を自動記録するAI、医師の好みと誤りがずれる**

商用3製品を模擬診察で比較。医師56人の高評価の製品が誤り最少ではなかった 出典 [JAMIA](#) ↗

〈小児／作業療法〉**脳性まひ児の手の訓練、カメラとAIで在宅に**

45人のRCT(対照は介入なし)。箱と積み木テスト等で改善、遵守91.9% 出典 [Disabil Rehabil](#) ↗

〈養成教育〉**理学療法の卒前教育ガイドライン第1版公開**

日本理学療法教育学会が協会の教育ガイドラインを引き継ぎ、養成教育の指針を示した 出典 [PT-OT-ST.NET](#) ↗

〈医療AI〉**網膜症AI、1病院から100万人超の検診へ**

インド・タイ・豪州での導入経験を整理した論評。成果データの原著ではない 出典 [Nature Medicine](#) ↗